Complexo de assistência social destinado a crianças e jovens com necessidades educacionais especiais que têm na arquitetura a ordenação da intersetorialidade entre educação e saúde.

Tema e fenômeno:

Jovens e crianças de baixa renda com demandas de necessidades educacionais especiais enfrentam uma lacuna de cuidado agravada pela fragmentação de setores assistenciais básicos. Organizações internacionais como UNICEF[1] associam essa vulnerabilidade à limitação ao acesso a serviços de saúde e educação, no âmbito da intersetorialidade.

Nesse panorama, cresce no setor público a demanda por atendimento educacional especializado, como recurso de atendimento educativo facilitador do desenvolvimento acadêmico[2], para um público de jovens e crianças com deficiência intelectual, motora, sensorial e múltipla; transtornos do neurodesenvolvimento (TEA e TDAH); superdotados; assim como os transtornos de aprendizagem com prejuízo na leitura, escrita e matemática. Evidencia-se que a resposta à fragmentação não se restringe ao campo educacional.

Diante disso, propõe-se o projeto de uma arquitetura modular sistêmica, cujos módulos educacionais e saúde, articulados pela assistência social, tornam-se ferramentas de aplicação dos princípios de intersetorialidade na abordagem das necessidades educacionais especiais, permitindo replicabilidade em diferentes contextos municipais.

Justificativa:

A Organização Mundial da Saúde compreende, como deficiência, impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo que, em interação com diversas barreiras, podem dificultar sua inclusão efetiva na sociedade. A OMS[3] estima que 317

[1] Debate publicado pelo Guia de Orientação do Resultado Sistêmico 7 (Selo UNICEF - 2023), sobre *Proteção Integral e Intersetorialidade via CRAS.*

[2] Público alvo identificado com Necessidades Educacionais Especiais pela Universidade de Algarve | Portugal.

3 Publicação realizada pela OMS (2023) como informativo de atenção e urgência para as causas de deficiências de jovens e crianças.

milhões de jovens e crianças foram afetados por condições de saúde que contribuem para deficiência no desenvolvimento.

No Brasil, o Artigo 04 da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (2025)[4], assegura recursos e serviços educacionais para apoiar, complementar e suplementar o processo de escolarização àqueles que dependem do atendimento educacional especializado. Público esse que cresceu em mais de 80% em matrículas durante os anos de 2021 e 2025 nas dependências administrativas públicas (INEP, 2025 – Censo Escolar).

No âmbito da assistência social, dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (2024) indicam que cerca de 870 mil crianças e adolescentes eram beneficiários do Benefício de Prestação Continuada por deficiência, dos quais 83,06% estavam matriculados na rede regular de ensino público. Ainda que esse percentual represente recorde histórico do programa, persiste uma parcela de aproximadamente 147 mil crianças e adolescentes que, mesmo amparadas pela assistência social, não têm acesso equivalente à educação.

Neste sentido, torna-se relevante porque identifica-se uma lacuna projetual na abordagem organizacional dos princípios da assistência social inclusiva, com ausência de articulação intersetorial da saúde e educação. Portanto, o trabalho contribui ao propor um equipamento arquitetônico concebido a partir do princípio ordenador da assistência social, com resposta projetual em um programa misto de setores equivalentes, replicável em diferentes contextos.

Objetivos:

Objetivo geral:

Projetar um complexo de assistência social destinado a crianças e jovens com necessidades educacionais especiais num mesmo equipamento.

Objetivos específicos:

I. Traduzir o princípio de intersetorialidade na articulação espacial do objeto entre educação e saúde;

[4] Artigo apresentado DECRETO Nº 12.686 (2025) que Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva.

II. Formular parâmetros e modulações que supram as lacunas organizacionais de ambientes de atendimento especializados;
III. Propor um espaço integralmente inclusivo sustentado pelo principio do Design Universal
IV. Traçar a replicabilidade territorial em escala bairro/município.

Revisão Literária:

Estudos e dados recentes reafirmam a necessidade de acolhimento intersetorial de crianças e jovens de baixa renda com necessidades educacionais especiais, sustentando a relevância de espaços que medeiem o desenvolvimento educacional e social.

Essa necessidade encontra justificativa em duas frentes integrativas: Ghalwash, Ali Sheta e Samra (2024), que argumentam que a flexibilidade da arquitetura acomoda diferentes estágios do desenvolvimento psicofisiológico infantil (físico, cognitivo, de raciocínio, linguagem, personalidade e social), fundamentais em espaços educacionais no estimulo e formação do jovem e da criança. Enquanto Jan Gehl (2013) afirma que a sensação de conforto e bem-estar é dependente das relações que podem ser criadas entre a estrutura do espaço e a presença do corpo humano. As duas abordagens convergem ao tratar o espaço como agente ativo da experiência, ainda que em escalas distintas, Gehl parte da cidade, os demais do indivíduo.

Essa justificativa se traduz por Salari e Westbrook (2024), dotados do ponto de vista pedagógico, descrevem os espaços mediados, como locais passíveis de trânsição entre aprendizagem formal e informal, favorecem o compartilhamento de conhecimentos e interações sociais. Justificando essa lógica, Dovey e Fischer (2014) já apontavam as tipologias espaciais que reorganizam o espaço em outras cinco principais categorias que vão além da sala de aula tradicional: "commons" (espaços de convivência), "streetspace" (espaços de circulação/rua interna), "meeting" (áreas de encontro), "fixed function" (espaços de função fixa) e "outdoor learning" (aprendizagem ao ar livre). Ambos os autores convergem ao propor variedade tipológica como resposta à diversidade de necessidades atendidas, ampliando a aprendizagem para além do espaço fechado e fixo.

Para organizar esse sistema de variedade tipológica e sistemática, este trabalho adota a *análise gama* desenvolvida por Hillier (1976), da qual envolve a criação de um mapa diagramático que busca identificar padrões morfológicos baseados em ambientes e um ponto de partida (acesso) com estruturas espaciais que contribuem para a criação do

espaço em tipologias de edifícios, permitindo traduzir a articulação entre os módulos de educação e saúde ordenados.

Conceitos estruturantes:

Atendimento Educacional Especializado:

Define o conjunto de recursos e serviços que apoiam, complementam ou suplementam o processo de escolarização de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais. Alabi et al. (2026) sustentam que esse atendimento deve ser compreendido para além da sala de aula, abrangendo também os espaços de apoio clínico e social que condicionam o desenvolvimento do estudante. Logo, o conceito é utilizado para compreender como o equipamento projetado deve acomodar, espacialmente, a diversidade de demandas (TEA, TDAH, deficiência, superdotados e transtornos de aprendizagem com prejuízo) atendidas pela proposta.

Articulação Intersetorial:

Refere-se à integração entre setores de educação, saúde e assistência social como resposta a demandas que nenhum deles atende isoladamente. Salari e Westbrook (2024) reforçam essa ideia ao descrever espaços mediados como zonas de transição capazes de favorecer o compartilhamento de conhecimento entre diferentes campos de atuação. Logo, o conceito é utilizado para compreender como a arquitetura viabiliza espacialmente a cooperação entre setores que, na prática institucional brasileira, permanecem fragmentados.

Reordenação Espacial:

Compreende o papel da arquitetura na estruturação do espaço como instrumento de articulação entre setores que possuem interdependência, mas que tradicionalmente não operam em conjunto. A partir da análise gama, Hillier (1976) demonstra que padrões morfológicos são capazes de induzir ou inibir relações entre ambientes de uma edificação. Já Dovey e Fischer (2014) reforçam a ideia ao propor tipologias espaciais que rompem com a setorização tradicional, favorecendo zonas de transição entre funções distintas.

Replicabilidade Territorial:

Refere-se à capacidade de um sistema arquitetônico se adaptar a diferentes contextos municipais sem perder sua lógica organizacional central. Hillier (1976), com a

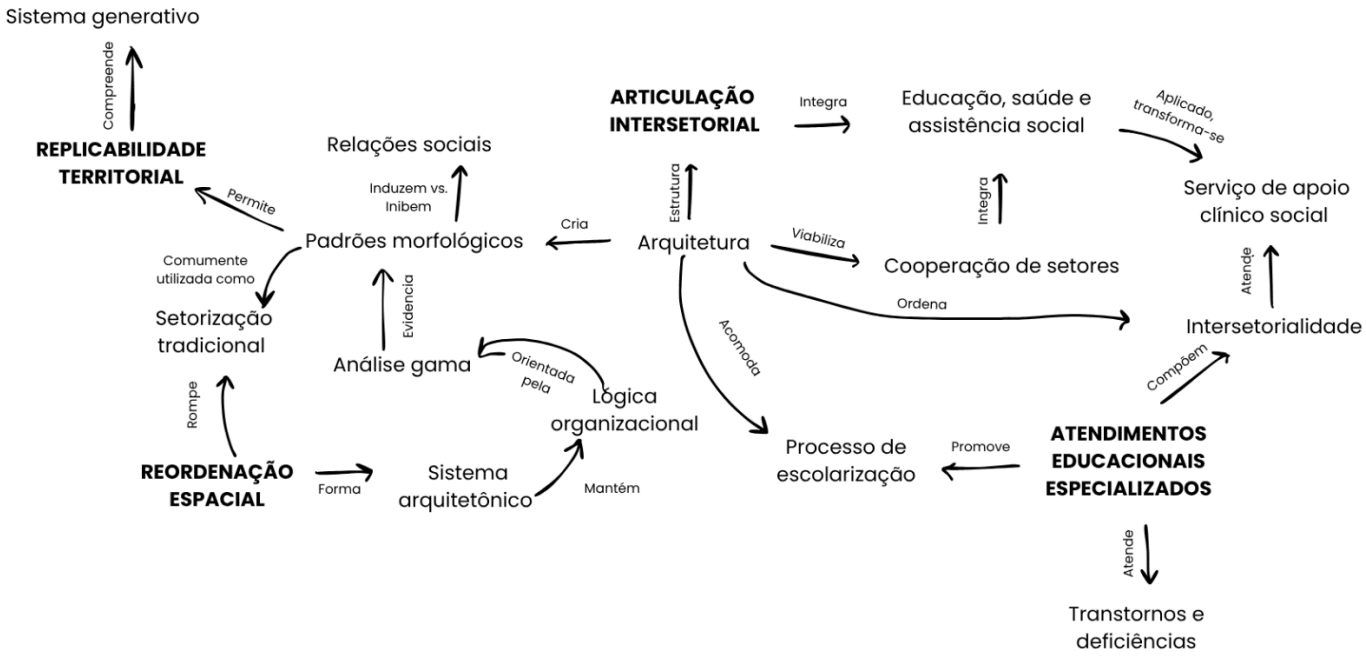
análise gama, reforça essa ideia ao demonstrar que padrões morfológicos permanecem identificáveis mesmo quando aplicados a diferentes tipologias e contextos. Compreendendo como o sistema generativo adotado garante que o princípio ordenador da assistência social se mantenha estável, ainda que a forma final do equipamento varie conforme contexto de implantação.

Síntese Interpretativa:

O atendimento a jovens e crianças com necessidades educacionais especializados depende dos espaços de apoio clínico e social que condicionam seu desenvolvimento. Neste sentido, a arquitetura e a articulação intersetorial evidenciam-se como ferramentas viabilizadora da cooperação de setores institucionais que, na prática projetual, encontram-se fragmentados pela falha de ordenação da assistência social sobre educação e saúde.

Como instrumento para superar essa falha, a reordenação espacial como estruturadora do ambiente, capaz de solucionar esta lacuna, replicável a diferentes diversos territórios, se desenvolve a partir da replicabilidade territorial, que garante que o princípio ordenador da assistência social se mantenha estável mas varie conforme o contexto de implantação. Esses conceitos orientam, assim, a organização espacialm decisão de programa de necessidades e implantação a serem investigadas nas etapas seguintes do projeto.

Diagrama Conceitual:



Referências:

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. **Proteção integral e intersetorialidade via CRAS.** UNICEF, 2023. *Disponível em: https://selounicef.org.br/sites/default/files/2023-06/Prote%C3%A7%C3%A3o%20Integral%20e%20Intersetorialidade%20via%20CRAS.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.*

UNIVERSIDADE DO ALGARVE. **O que são Necessidades Educativas Especiais (NEE)?** Universidade do Algarve. *Disponível em: https://www.ualg.pt/atendimento/o-que-sao-necessidades-educativas-especiais-nee. Acesso em: 24 set. 2026.*

BRASIL. Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. *Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/d12686.htm. Acesso em: 24 set. 2026.*

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira**. Notas estatísticas do Censo Escolar da Educação Básica 2025**. Brasília, DF: Inep, 2026. *Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2025.pdf. Acesso em: 27 set. 2026.*

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Resumo técnico: Censo da Educação Básica 2025. Brasília, DF: Inep, 2026**. *Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_da_educacao_basica_2025.pdf. Acesso em: 27 set. 2026.*

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Portal de analytics e estatísticas do Inep. Brasília, DF: Inep, [2026]**. *Disponível em: https://anonymousdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal. Acesso em: 27 set. 2026.*

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Informativo Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2026**. *Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102317_informativo.pdf. Acesso em: 27 set. 2026.*

MUNDO. Organização Mundial da Saúde. **New report highlights neglected health needs of children with developmental disabilities**. Genebra: OMS, 15 set. 2023. *Disponível em: https://www.who.int/news/item/15-09-2023-new-reports-highlights-neglected-health-needs-of-children-with-developmental-disabilities. Acesso em: 29 set. 2026.*

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. **BPC na Escola registra recorde histórico com 83,06% de beneficiários matriculados em 2024.** Brasília, DF: MDS, 2026. *Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social. Acesso em: 29 set. 2026.*

BRASIL. Ministério da Educação. **Cadernos pedagógicos PNEEI: volume 12. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2026**. *Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/pneei/arquivos/cadernos-pedagogicos-pneei-vol-12. Acesso em: 29 set. 2026.*

GEHL, Jan. **Cidades para pessoas.** Tradução de Anita Di Marco. São Paulo: Perspectiva, 2013

GHALWASH, Omnia Reda Mohamed; ALI SHETA, Sherif Ahmed & SAMRA, Medhat Ahmed Shabaan. **Adaptive socio-economic design approach for schooling systems in Egypt's poorest areas (an applied project)**. HBRC Journal, 20:1, 153-178, 2024. *DOI: 10.1080/16874048.2024.2303797. Disponível em: https://doi.org/10.1080/16874048.2024.2303797. Acesso em: 08 out. 2026*

SALARI, Elia Ebrahimi; WESTBROOK, Nigel. **Ascending to well-being through mediated spaces: an alternative to informal learning and physical activity environments in vertical schools.** Architectur, v. 4, n. 3, p. 613-638, 2024. *DOI: https://doi.org/10.3390/architecture4030032. Disponível em:* https://www.mdpi.com/2673-8945/4/3/32. Acesso em: 08 out. 2026.

ALABI, et al. **Architectural design and spatial requirements for meeting learning needs in special children's schools: a case study of Lagos, Nigeria**. Discover Education, [S. l.], v. 5, art. 240, 2026. *DOI: https://doi.org/10.1007/s44217-026-01172-y. Disponível em https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-026-01172-y. Acesso em: 12 out. 2026.*